



HISTÓRIA DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DO BRASIL E DO MUNDO

Profa. Michelle Sampaio



Colonização e Império





Pouco ou nada feito em relação à saúde pública no Brasil

- Ausência de Políticas estruturadas;
- Ausência de construção de centros de atenção à saúde da população;
- Acesso a atendimento médico condicionado à classe social;
- Curandeirismo e Utilização de plantas medicinais.



Chegada da Família Real ao Brasil (1808)

- Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro e o Colégio Médico-Cirúrgico no Real Hospital Militar de Salvador;
- Santas Casas de Misericórdia: as Santas Casas de Santos (1543), Salvador (1549), Rio de Janeiro (1567), Vitória (1818), São Paulo (1599), João Pessoa (1602), Belém (1619), entre diversas outras.
- Constituição Imperial de 1824 organização jurídica das Santas Casas de Misericórdia.
- D. Pedro II – Criação de órgãos para vistoriar a higiene pública.



República Velha (1889-1930)

- Fim da escravidão em 1888: Brasil dependente de mão de obra de imigrantes.
- Para o governo, o crescimento do país dependia de uma população saudável e com capacidade produtiva.





Oswaldo Cruz e o Sanitarismo Campanhista

- 1903 – Diretoria Geral de Saúde Pública
- Febre amarela
- Peste Bulbônica
- Varíola
- Revolta da Vacina (1904)





1923 – CAPS Lei Eloy Chaves

Por instituição ou empresas

Financiamento e gestão: trabalhador e empregador

Aposentadoria, pensão e assistência médica



1933 – Unificação das CAPS em IAPs

Por categorias profissionais

Financiamento e gestão tripartite: Estado, Trabalhador e Empresa

Aposentadoria, pensão e assistência médica



1953 – Criação do Ministério da Saúde

- O Ministério da Saúde foi instituído em 25/7/1.953;
- [Lei nº 1.920](#), que desdobrou o então Ministério da Educação e Saúde em dois ministérios: Saúde e Educação e Cultura.
- limitava-se a ação legal e a mera divisão das atividades de saúde e educação, antes incorporadas num só ministério.
- MS passou por diversas reformas em sua estrutura organizacional. Destaca-se a reforma de 1.974, na qual as Secretarias de Saúde e de Assistência Médica foram englobadas, passando a constituir a Secretaria Nacional de Saúde, para reforçar o conceito de que não existia dicotomia entre saúde pública e assistência médica.



Estrutura MS

- **Secretarias:**
 - Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
 - Secretaria de Atenção Primária à Saúde
 - Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde
 - Secretaria Especial de Saúde Indígena
 - Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
 - Secretaria de Vigilância em Saúde
- **Órgãos vinculados:**
 - [Agência Nacional de Vigilância Sanitária \(ANVISA\)](#)
 - [Agência Nacional de Saúde Suplementar \(ANS\)](#)
 - [Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia \(HEMOBRÁS\)](#)
 - [Fundação Oswaldo Cruz \(FIOCRUZ\)](#)
 - [Fundação Nacional de Saúde \(FUNASA\)](#)



Treino

4. (Ano: 2015 Banca: IBFC Órgão: EBSEERH Provas: IBFC - 2015 –Enfermeiro) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto à implantação da Reforma Administrativa Federal, quando ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde e ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

A) 1963.

B) 1969.

C) 1956.

D) 1961.

E) 1967.



HISTÓRIA DO MS

Com a implantação da Reforma Administrativa Federal, em 25 de fevereiro de 1967, ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde, que até então não havia saído do papel. Ficaram as seguintes áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.



05. Ano: 2015 Banca: IBFC Órgão: EBSEERH) Assinale a alternativa correta sobre a evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto ao ano em que as Secretarias de Saúde e de Assistência Médica foram englobadas, passando a constituir a Secretaria Nacional de Saúde, para reforçar o conceito de que não existia dicotomia entre Saúde Pública e Assistência Médica.

A) 1990

B) 1956

C) 1974

D) 1967

E) 1969



HISTÓRIA DO MS

O Ministério da Saúde passou por diversas reformas na estrutura. Destaca-se a reforma de 1974, na qual as Secretarias de Saúde e de Assistência Médica foram englobadas, passando a constituir a Secretaria Nacional de Saúde, para reforçar o conceito de que não existia dicotomia entre Saúde Pública e Assistência Médica.



HISTÓRIA DO MS

O Ministério da Saúde passou por diversas reformas na estrutura. Destaca-se a reforma de 1974, na qual as Secretarias de Saúde e de Assistência Médica foram englobadas, passando a constituir a Secretaria Nacional de Saúde, para reforçar o conceito de que não existia dicotomia entre Saúde Pública e Assistência Médica.



1966 – Criação do INPS

- Criado como órgão de administração indireta da União, com personalidade jurídica autárquica e vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social.
- o INPS passou a conceder benefícios pecuniários e assistência médico-hospitalar aos trabalhadores urbanos do setor privado e aos funcionários públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Os demais servidores públicos continuaram a manter seu próprio instituto, o Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado (IPASE).



Principal característica do modelo INPS

Entre as diretrizes adotadas pelo INPS destacou-se:

Política de assistência médica com prioridade para a contratação de serviços de terceiros, em detrimento dos serviços médicos próprios da previdência social.

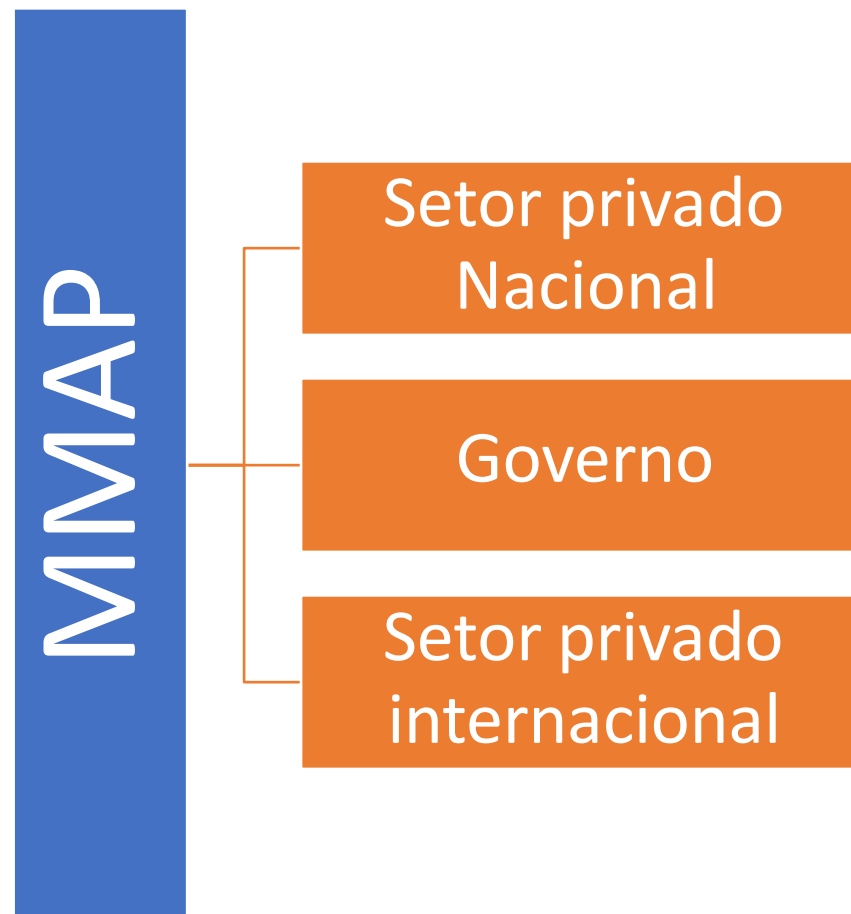
O funcionamento dessa política de privilegiar a da empresa privada obedeceu a três mecanismos básicos:

- 1) o financiamento de hospitais privados,
- 2) o credenciamento de hospitais para a compra de serviços pelo INPS, e
- 3) o convênio com empresas, através do qual o INPS lhes devolvia parte de sua contribuição previdenciária desde que elas assumissem os encargos de assistência médica a seus empregados.

Outro aspecto importante dessa primeira fase de atuação do INPS foi a incorporação, em 1967, do seguro contra acidentes de trabalho, antiga reivindicação dos trabalhadores que esbarrava na resistência das companhias privadas de seguro.

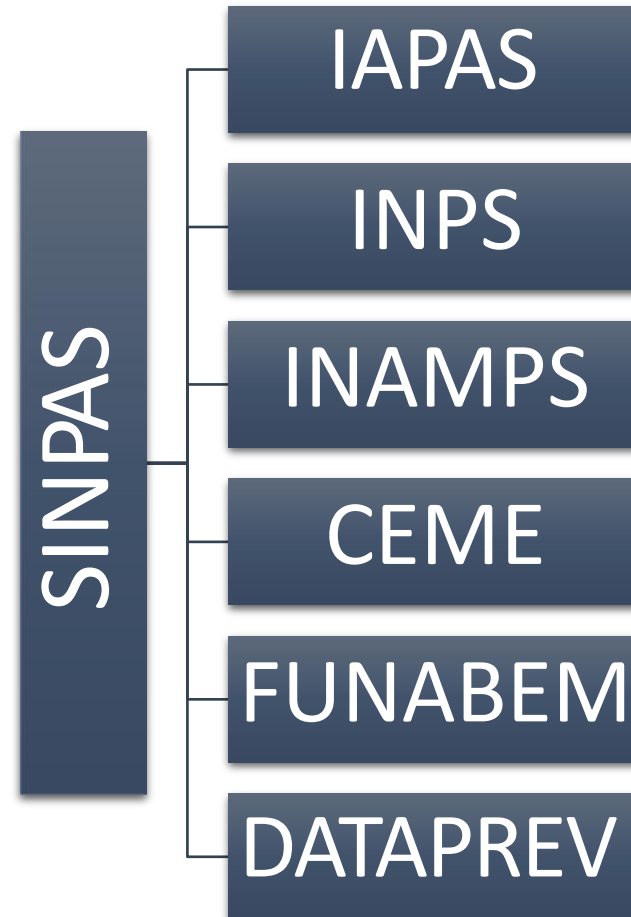


MMAP





1977 - SINPAS





1977 - INAMPS

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INAMPS)

O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), autarquia federal, foi criado em 1977, pela Lei nº 6.439, que instituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (Sinpas), definindo um novo desenho institucional para o sistema previdenciário, voltado para a especialização e integração de suas diferentes atividades e instituições. O novo sistema transferiu parte das funções até então exercidas pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) para duas novas instituições. A assistência médica aos segurados foi atribuída ao INAMPS e a gestão financeira, ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (Iapaf), permanecendo no INPS apenas a competência para a concessão de benefícios.

O INAMPS foi extinto em 1993, pela Lei nº 8.689, e suas competências transferidas às instâncias federal, estadual e municipal gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Constituição de 1988, que consagrou o direito universal à saúde e a unificação/descentralização para os estados e municípios da responsabilidade pela gestão dos serviços de saúde.





1978 – Declaração de Alma-Ata

- 1ª Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde ocorrida em Alma-Ata,
- Tem sido considerada como a primeira declaração internacional que despertou e enfatizou a importância da atenção primária em saúde, desde então defendida pela [OMS](#) como a chave para uma promoção de saúde de caráter universal.
- Os primeiros itens da declaração reafirmam a definição de saúde defendida pela OMS, como o “completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade”, e a defendem como direito fundamental e como a principal meta social de todos os governos.
- A seguir a declaração salienta a interferência da desigualdade social nas políticas de saúde, ressaltando o papel que a lacuna entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento representa. Exortando todos os países à cooperação, na busca pelo objetivo comum da saúde, fator que contribui para a qualidade de vida e para a paz mundial, a declaração defende tal cooperação como direito e dever de todos, individual e coletivamente.
- Segue-se a reafirmação da responsabilidade de todos os governos pela promoção de saúde, e a reivindicação da atenção primária como fator de viabilidade para uma universalização dos cuidados, mediante a abrangência e a melhoria social que possibilitam, integrando governo com todos os setores da sociedade, em prol da igualdade social.



Movimento Sanitarista

- O movimento sanitaria foi de importância ímpar ao entendimento de saúde pública, do conceito de saúde e também da evolução do direito à saúde no Brasil. A reforma sanitária se refere às ideias de uma série de mudanças e transformações necessárias à saúde. Sua composição era de técnicos da saúde – médicos, enfermeiros, biomédicos... – e intelectuais, partidos políticos, diferentes correntes e tendências e movimentos sociais diversos. Ao fim da década de 1970, o movimento adquiriu certa maturidade em função de uma série de estudos acadêmicos e práticos realizados, principalmente, nas faculdades de Medicina. Nas universidades, o entendimento de medicina se tornava cada mais social, pensando a saúde como uma série de fatores que vão além do bem-estar do corpo humano.



Movimento Sanitarista

- De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), alguns dos atores do movimento sanitaria foram os médicos residentes, “que na época trabalhavam sem carteira assinada e com uma carga horária excessiva”, por exemplo. Outras movimentações da Reforma Sanitária foram as primeiras greves realizadas depois de 1968 e os sindicatos médicos, que também estavam em fase de transformação.
- “Esse movimento entra também nos conselhos regionais, no Conselho Nacional de Medicina e na Associação Médica Brasileira – as entidades médicas começam a ser renovadas. A criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), em 1976, também é importante na luta pela reforma sanitária. A entidade surge com o propósito de lutar pela democracia, de ser um espaço de divulgação do movimento sanitário, e reúne pessoas que já pensavam dessa forma e realizavam projetos inovadores”, de acordo com a Fiocruz.
- Enquanto a ditadura militar existia, o movimento sanitaria foi “testando” uma série de hipóteses a respeito do seu entendimento de saúde. Na Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp) da Fundação Oswaldo Cruz são colocados em prática diversos projetos “e pessoas que faziam política em todo Brasil foram treinadas”. Os projetos envolviam:



- (1976) Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes).
- (1979) Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco).
- Em meados dos anos 1980, Sergio Arouca assumiu a Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro.



1981/1982 – Plano CONASP

- CONASP – Conselho Nacional de Administração da Saúde Previdenciária, subordinado diretamente ao Presidente da República, efetivada pelo Decreto 86329, de setembro de 1981.



1983 – Ações Integradas em Saúde

- “A partir do plano do CONASP, foi implementada a estratégia das Ações Integradas de Saúde – AIS, visando alcançar níveis de articulação institucional que viabilizassem ações mais eficientes e eficazes”.



1986 – VIII Conferência Nacional de Saúde

- Diretrizes para construção do SUS
- A saúde como dever do Estado e direito do cidadão;
- A reformulação do Sistema Nacional de Saúde;e
- O financiamento setorial.



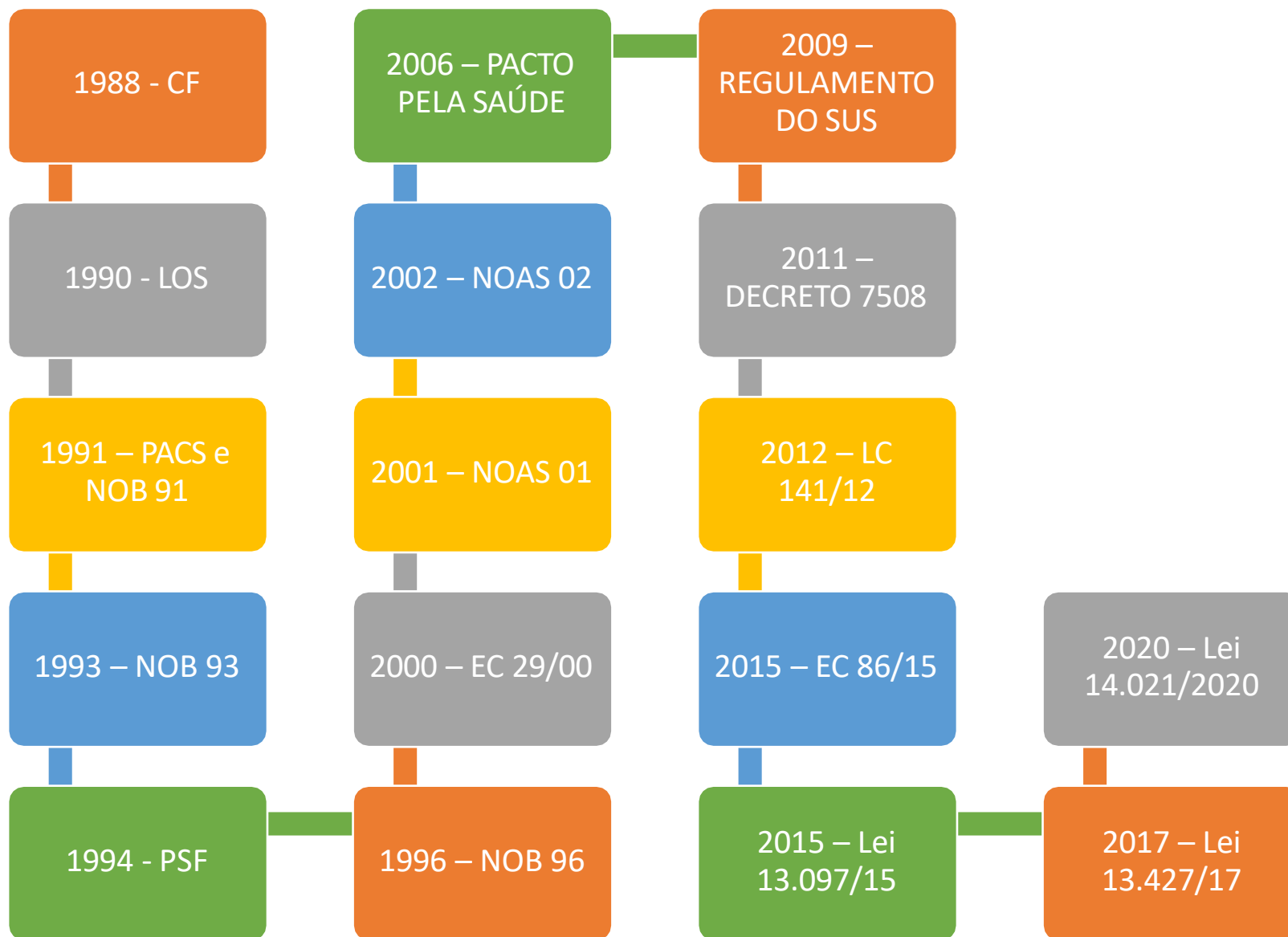
1987 - SUDS

- Esse processo culminou com a publicação do Decreto nº. 94.657, de julho de 1987 que cria o Programa de Desenvolvimento de Sistemas Unificados e Descentralizado de Saúde nos Estados – SUDS. Esse Programa foi, implementado por meio da celebração de convênios entre o INAMPS e os Governos Estaduais.
- O SUDS teve como principais objetivos: a unificação dos sistemas (Ministério da Saúde e INAMPS - Ministério da Previdência e Assistência Social) com consequente universalização da cobertura e a descentralização.



1988 – Constituição Federal do Brasil

- A Constituição Federal de 1988 foi o primeiro documento a colocar o direito à saúde definitivamente no ordenamento jurídico brasileiro. A saúde passa a ser um direito do cidadão e um dever do Estado. A Constituição ainda determina que o sistema de saúde pública deve ser gratuito, de qualidade e universal, isto é, acessível a todos os brasileiros e/ou residentes no Brasil.
- O Sistema Único de Saúde foi regulado posteriormente pela lei 8.080 de 1990, em que estão distribuídas todas as suas atribuições e funções como um sistema público e pela lei 8.142, também de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade, gestão e financiamento do SUS. Você poderá ler sobre o SUS em diversos outros textos na nossa trilha sobre saúde pública.





Modelos de Atenção a saúde no mundo



Modelo Universalista

- Maior ou todo o financiamento público
- Acesso Universal
- Serviços prestados por fornecedores públicos



Modelo do Seguro Social

- Participação obrigatória
- Financiamento por aporte de empresários e trabalhadores
- Só cobrem contribuintes e familiares



Seguro Privado/Misto/Residual

- Fragmentado;
- Descentralizado;
- Escassa regulação do Estado



TREINO

6. (FCC - 2019 - Prefeitura de São José do Rio Preto - SP - Agente Administrativo) A análise da evolução das políticas de saúde no Brasil mostra que

- A) a centralização de ações de saúde tem sido a tendência das últimas décadas.
- B) houve migração do modelo curativo para o modelo preventivo.
- C) a atenção primária, ou básica, está sendo substituída pela atenção terciária.
- D) as políticas voltadas à saúde de segmentos populacionais, como pessoa idosa, estão sendo abandonadas.
- E) os programas de promoção à saúde foram substituídos por aqueles de proteção à saúde.